

REVISÃO OSCE III - Maria Luíza Bernardino e Maria Alice Fernandes

SEMANA 1: Método SOAP

→ **S:** subjetivo

Motivo do atendimento, anamnese, problema(s), sentimentos.

→ **O:** objetivo

Dados do exame físico e/ou resultados dos exames complementares.

→ **A:** avaliação

Hipóteses diagnósticas e problemas evidenciados na consulta (ex.: HAS, DM).

→ **P:** plano

Proposta terapêutica elaborada: medicações prescritas, solicitações de exames complementares, orientações realizadas, encaminhamentos e pendências para o próximo atendimento.

SEMANA 2: PROTOCOLO SPIKES

→ **S:** Setting up

- Procure por um lugar calmo e que permita que a conversa seja particular.
- Mantenha um acompanhante com seu paciente.
- Sente-se e procure não ter objetos entre você e seu paciente.
- Escute atentamente o que o paciente diz.

→ **P:** Perception

Procure saber o que o paciente já sabe do que está acontecendo. Procure usar perguntas abertas.

(ex.: o que você acha que está acontecendo?; você acha que é algo grave?)

→ **I:** Invitation

Identifique até onde o paciente quer saber do que está acontecendo, se quer ser totalmente informado ou se prefere que um familiar tome as decisões por ele.

(ex.: os resultados não saíram como o esperado, você gostaria que eu os explicasse?; Você é o tipo de pessoa que gosta de saber exatamente o que está acontecendo?)

→ **K:** Knowledge

- Introduções como “infelizmente não trago boas notícias” podem ser um bom começo.

- Use sempre palavras adequadas ao vocabulário do paciente.

- Use frases curtas e pergunte, com certa frequência, como o paciente está e o que está entendendo.

→ **E:** Emotions

Aguarde a resposta emocional que pode vir, dê tempo ao paciente, ele pode chorar, ficar em silêncio, em choque. Mantenha sempre uma postura empática. (ex.: Sei que as notícias não saíram como o esperado, sinto muito.)

→ **S:** Strategy and Summary

Abordar um plano ou tratamento, curativo ou não. Pergunte se o paciente apresenta alguma dúvida.

1. Apresentou-se ao paciente e o cumprimentou (Nome, função e convidou o paciente a se sentar)
2. Perguntou se gostaria que algum familiar ou amigo participasse do atendimento
3. Indagou sobre o que o paciente sabia sobre o seu caso até o momento
4. Avisou que más notícias estavam por vir para diminuir o choque da transmissão das notícias
5. Fez escuta ativa (Contato visual, expressão facial, vocalizações ou gestos demonstrando interesse e respeito)
6. Avaliou o quanto o paciente quer saber
7. Informou o resultado de maneira adequada (Linguagem clara e acessível)
8. Forneceu a informação pouco a pouco
9. Conferiu periodicamente a compreensão do paciente
10. Fez o silêncio necessário para a reação do paciente
11. Ofereceu conforto ao paciente
12. Manteve as esperanças do paciente
13. Foi empático com o paciente e observou suas emoções
14. Fez explicação curta com as informações necessárias: possibilidade de terapia
15. Fez explicação curta com as informações necessárias: possibilidade de cura
16. Colocou-se à disposição para posteriores dúvidas
17. Discutiu a marcação de consulta de retorno
18. Não cometeu erros: minimizou a gravidade (Insistindo em apresentar o “lado bom” da situação ou diminuindo o problema)
19. Não cometeu erros: evitação (não adiou ou evitou a comunicação)

SEMANA 3 e 4: ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO CARDIOVASCULAR E IC

*Olhar calculadora SBC!

1. Mãos:

- Arachnodactilia: dedos das mãos e dos pés anormalmente longos e delgados, característicos da Síndrome de Marfan, que está associada ao prolapso da valva mitral/aórtica e a dissecção da aorta.

- Sinal da Janela: baqueteamento digital que envolve o inchaço do tecido mole da falange que está associado a várias doenças cardiovasculares. Em pacientes com baqueteamento digital a janela é perdida.

2. **Pressão Venosa Jugular:** fornece uma medida indireta da pressão venosa central. Isso é possível porque a veia jugular interna (VJI) se conecta ao átrio direito sem nenhuma válvula intermediária, resultando em uma coluna contínua de sangue.

- Posicione o paciente em posição semi-reclinada (a 45°).

- Peça ao paciente para virar a cabeça ligeiramente para a esquerda.

- Verifique se há evidências de VJI, passando entre a extremidade medial da clavícula e o lóbulo da orelha, sob a face medial do esternocleidomastóideo (pode ser visível logo acima da clavícula, entre as cabeças esternal e clavicular do esternocleidomastóideo).

obs.: A VJI tem uma pulsação em forma de onda dupla, o que ajuda a diferenciá-la da pulsação da artéria carótida externa.

- Meça a JVP avaliando a distância vertical entre o ângulo esternal e o topo do ponto de pulsação da VJI (em indivíduos saudáveis, não deve ser maior que 3 cm).

3. Teste de refluxo hepatojugular

- O teste de refluxo hepatojugular envolve a aplicação de pressão no fígado enquanto se observa um aumento sustentado na JVP.

- Posicione o paciente em posição semi-reclinada (45°).

- Aplique pressão direta no fígado.

- Intimamente observar o IJV para um aumento.

- Em indivíduos saudáveis, esse aumento não deve durar mais do que 1-2 ciclos cardíacos (deve cair).

- Se o aumento em JVP for sustentado e igual ou superior a 4 cm, este é considerado um resultado positivo.

4. Edema

- Inspeção e apalpe os tornozelos do paciente em busca de evidências de edema de pedal (associado a insuficiência ventricular direita).

5. Fatores de risco

- Hipertensão

- Infarto do miocárdio

- Válvulas cardíacas anormais

- Cardiomiopatia

- Histórico familiar de doença cardíaca.

- Diabetes

- Tabagismo

- Obesidade.

6. Critérios de Framingham (2M ou 1M e 2m)

CRITÉRIOS MAIORES	CRITÉRIOS MENORES
Dispnea paroxística noturna	Tosse noturna
Perder 4,5 kg em 5 dias	Capacidade vital reduzida a 1/3 do normal
Turgência jugular patológica	Edema bilateral em tornozelos
Estertores crepitantes	Dispneia aos esforços
Edema agudo de pulmão	hepatomegalia
Pressão venosa central > 16cm H ₂ O	Taquicardia com FC > 120bpm
Refluxo hepatojugular	
Cardiomegalia no RX	
Terceira bulha (B3)	

7. Classificação NYHA

CLASSE	DEFINIÇÃO	DESCRIÇÃO GERAL
I	Ausência de sintomas	Assintomático
II	Atividades físicas habituais causam sintomas. Limitação leve	Sintomas moderados
III	Atividades físicas menos intensas que os habituais causam sintomas. Limitação importante, porém, confortável no repouso.	Sintomas moderados
IV	Incapacidade para realizar atividade sem apresentar desconforto. Sintomas no repouso.	Sintomas graves

8. Classificação AHA

Tabela 21.4. Classificação da AHA

A	Com fatores de risco, mas sem doença estrutural perceptível
B	Com lesão estrutural cardíaca, mas sem sintomas de IC
C	Com lesão estrutural cardíaca e com sintomas atuais ou prévios de IC
D	Com lesão estrutural cardíaca e com sintomas refratários ao tratamento convencional

SEMANA 5: REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA

Referência compreende-se o trânsito do nível menor para o de maior complexidade.

Inversamente, a contrarreferência compreende o trânsito do nível de maior para o de menor complexidade.

Ex.: Paciente queixa de dor torácica e cianose ao esforço, o médico da UBS tem como hipótese diagnóstica sopro sistólico após realizar ausculta no paciente. Sendo assim, encaminha (referência) paciente para um cardiologista. Após consulta com cardiologista, o paciente retorna ao médico da UBS para apresentar conclusão diagnóstica e exames feitos pelo especialista.

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA / CONTRA-REFERÊNCIA ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CONFIDENCIAL	
A contra referência é importante para a manutenção e acompanhamento dos pacientes	
Unidade responsável pelo encaminhamento:	Telefone Unidade:
Nome do paciente: _____ Nº IPSM: _____	
Idade: _____ Militar ☐ Posto/Grad: _____	Unid. vinculação do paciente: _____
Dependente ☐ Grau de parentesco: _____	Nº IPSM: _____
Responsável pelo paciente / Acompanhante: _____	
Parentesco: _____	Telefone: _____
DADOS DO REFERENCIAMENTO	
Referenciado à instituição/ ao especialista: _____	
Nome da instituição	Telefone: _____
Motivo do encaminhamento	
DADOS DO CONTRA-REFERENCIAMENTO	
Parcer do profissional especialista da unidade referenciada (tratamento indicado, medicação prescrita, sugestão de conduta terapêutica).	
Nome e carimbo do especialista	
Data: ____/____/____	

SEMANA 6: SÍNDROME CORONARIANA AGUDA

1. Anamnese:

- **Tempo:** quando que iniciou a dor? Ela é contínua? Quando a dor começou o

senhor estava fazendo o quê? Duração? (Fator precipitante).

- **Intensidade:** de 0 a 10

- **Localização:** onde começou? O senhor pode apontar para mim o local? A dor está migrando/espalhando para outro lugar (irradiando)?

- **Qualidade da dor:** esta dor está como? pressão? Fisgada? Aperto? Desconforto? Observar sinal de Levine.

- **Sintomas relacionados:** o senhor está sentindo mais alguma coisa junto? Falta de ar? Tontura? Náusea?

- **Fatores de alívio ou de estímulo:** quando essa dor surgiu o senhor estava fazendo o que ? O que piora essa dor? Você já sentiu essa dor em outras ocasiões? Surge aos esforços habituais? Perguntar se fez alguma coisa para melhorar, em repouso melhora? O senhor tomou alguma medicação para essa dor ?

2. Fatores de risco:

- História familiar de DAC prematura (familiar de 1º masculino antes dos 55 anos e do sexo feminino antes dos 65 anos);

- Idade: Homem > 45 anos ou mulher > 55 anos;

- Tabagismo;

- Hipercolesterolemia;

- Diabetes mellitus;

- Obesidade;

- Sedentarismo;

- Dieta pobre em frutas e vegetais;

- Estresse psicossocial;

- Artrite reumatoide.

Obs.: HAS – DM – dislipidemia – história familiar – tabagismo: 3 ou mais desses fatores em conjunto constituem um marcador independente de pior prognóstico.

3. Classificação

DOR DEFINITIVAMENTE ANGINOSA: dor ou desconforto retroesternal/precordial, geralmente precipitada pelo esforço físico, podendo se irradiar para o ombro, mandíbula ou face interna do braço (ambos), dura minutos e aliviada por repouso ou nitrato em menos de 10 minutos

PROVAVELMENTE ANGINOSA: tem a maioria, mas não todas as características da dor definitivamente anginosa.

PROVAVELMENTE NÃO ANGINOSA: tem poucas características da dor definitivamente anginosa ("dor atípica", sintomas de "equivalente anginoso")

DEFINITIVAMENTE NÃO ANGINOSA: nenhuma característica da dor anginosa, fortemente indicativa de diagnóstico não cardiológico.

Obs.: Idosos, mulheres e diabéticos frequentemente apresentam sintomas atípicos para a SCA.

CARACTERÍSTICA	ALTO	MODERADO	BAIXO
História	Idade = ou > 75 anos; diabetes; Dor progressiva, sintomas nas últimas 48 horas.	Idade 70-75 anos; IAM prévio; doença vascular periférica; cirurgia de revascularização miocárdica; uso prévio de AAS (última semana)	
Dor precordial	Prolongada (> 20 min), em repouso.	Prolongada (>20 min), em repouso, mas com alívio espontâneo ou nitrato.	Sintomas novos de angina classe III ou M da CCS nas últimas 2 semanas sem dor em repouso prolongada (>20 min.)
Exame Físico	Edema pulmonar; piora ou surgimento de sopro de regurgitação mitral B3, hipotensão; bradicardia e taquicardia.		
ECG	Infra desnível do segmento ST 0,5mm (associado ou não a episódio anginoso); alteração dinâmica do ST; bloqueio completo de ramo novo ou presumidamente novo; taquicardia ventricular sustentada.	Inversão da onda T>2mm; ondas Q patológicas.	Normal ou inalterado durante o episódio de dor.
Marcadores bioquímicos de dano miocárdio	Acentuadamente elevados (>0,6 ng/ml)	Elevados discretamente (0,1 – 0,5ng/ml)	Normais (0 – 0,05ng/ml)

4. Exame físico:

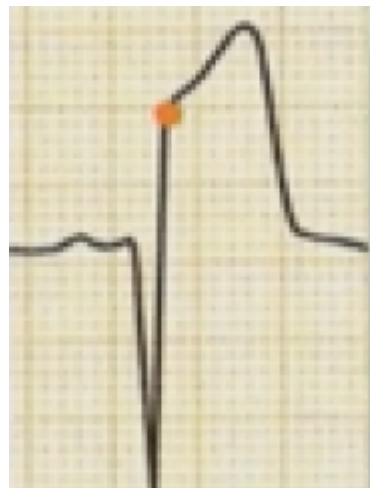
- Sinais vitais
- Inspeção: paciente sudorético, angustiado, hipoxemia, cianose.
- PA: avaliar simetria
- Palpação de pulsos do MMSS e MMII, avaliar simetria e tônus
- Ausculta cardíaca: sopros, B4, ictus deslocado, B3
- Ausculta pulmonar: estertores crepitantes
- Extremidades: procurar sinais de insuficiência ventricular – edema, pele fria, cianose (má perfusão)

Obs.: Sinais de maior gravidade e pior prognóstico: estertores pulmonares e B3, sinais de disfunção do VE, sopro.

5. Exames solicitados:

- ECG: supradesnívelamento de ST $\geq$ 1mm em derivações contínuas (ex.: V1e V2). A exceção para isso são as derivações V2 e V3, em que:

- Homem < 40 anos: J $\geq$ 2,5mm;
- Homem $\geq$ 40 anos: J $\geq$ 2mm;
- Mulheres: J $\geq$ 1,5mm.



POSIÇÃO DOS ELETRODOS DO ECG NAS DERIVAÇÕES PRECORDIAIS

EnfConcursos

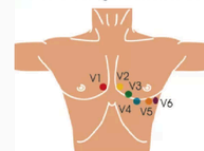
- V1:** Eletrodo na borda esternal do 4° EIC direito (Linha paraesternal)
- V2:** Eletrodo na borda esternal do 4° EIC esquerdo (Linha paraesternal)
- V3:** Eletrodo colocado entre o V2 e V4
- V4:** Eletrodo no 5° EIC esquerdo, na linha hemiclavicular
- V5:** Eletrodo no mesmo nível de V4, na linha axilar anterior
- V6:** Eletrodo no mesmo nível de V5, na linha axilar média

Atenção: Em pacientes com IAM, se houver suspeita de acometimento de parede posterior, pode ser utilizado o V7 e V8. (geralmente se utiliza os cabos de V5 e V6).

Suas localizações são:

V7: 5° EIC, linha axilar posterior

V8: 5° EIC, linha hemi-escapular



EnfConcursos

SALVE A DICA



vpav

- Enzimas cardíacas: CKMB e Troponina.

6. Conduta: MONABCH

- Morfina (alternativa de analgesia)
- Oxigenação
- Nitrato/nitroglicerina
- AAS
- Betabloqueador
- Clopidogrel (antiagregante plaquetário)
- Heparina (anticoagulante)

7. Tratamento:

- IAM com supra de ST e biomarcadores presentes: Se o tempo porta-balão for de até 90 minutos enviar para o cateterismo, se o local não tiver serviço de hemodinâmica, transferir o paciente desde que o tempo de locomoção até o procedimento não exceda 120 minutos. Com a impossibilidade do cateterismo, realizar o trombolítico: Ateplase e administrar junto enoxeparina.
- IAM sem supra de ST (eletro normal ou com infra/alterações de onda T), porém biomarcadores presentes:
Paciente de risco intermediário – iniciar anticoagulação (enoxeparina)
Paciente de alto risco- acrescentar clopidogrel
- Angina instável: sem alterações no ECG e sem elevação de biomarcadores.

SEMANA 7: VALVOPATIAS

1. Estenose mitral

- Quadro clínico: palpitações, rouquidão (síndrome de Ortner) e todas as valvopatias podem evoluir com sintomas de IC (dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna, edema periférico) -> mau prognóstico.
- Exame físico: sopro diastólico em ruflar
- Diagnóstico: melhor ECO

TABELA 7.3 Classificação da estenose mitral

Estenose mitral	Gradiente médio transvalvar (mmHg)	Pressão sistólica arterial pulmonar (mmHg)	Área valvar (cm ²)
Leve	< 5	< 30	> 1,5
Moderada	5-10	30-50	1,0-1,5
Grave	> 10	> 50	< 1,0

2. Estenose aórtica:

- Quadro clínico: tríade - dispneia, angina e síncope.
- Exame físico: sopro sistólico de ejeção.

3. Insuficiência aórtica:

- Exame físico: sopro diastólico aspirativo/protodiastólico; Sopro de Austin-Flint (estenose mitral relativa a uma insuficiência aórtica); sinal de Corrigan (pulso em martelo d'água), sinal de musset (movimentação da cabeça); sinal de muller (pulsção da úvula), sinal de quinke (pulsção da unha);sinal de Hill (diferença da PA dos MMII > 20mmHg em comparação com os MMSS).

4. Insuficiência mitral:

- Exame físico: sopro sistólico regurgitativo.

SEMANA 8: TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

- Anamnese: dor torácica pleurítica, dispnéia aos esforços ou em repouso, hemoptise.

- Diagnóstico: Escore de Wells

Variável Clínica	Pontuação
Câncer ativo (tratamento atual ou nos últimos 6 meses ou em cuidados paliativos).	+1
Paralisia, parestia ou imobilização recente dos membros inferiores.	+1
Acamado há ≥ 3 dias ou cirurgia maior nas últimas 12 semanas.	+1
Dor localizada no trajeto do sistema venoso profundo.	+1
Edema de todo membro inferior.	+1
Edema de panturrilha com pelo menos 3 cm de diâmetro maior do que a outra perna, (medindo 10 cm abaixo da tuberosidade tibial).	+1
Edema compressivo (cálcio) apenas na perna sintomática.	+1
Veias colaterais superficiais (não varicosas).	+1
TVP prévia documentada.	+1
Diagnóstico alternativo mais provável que TVP.	-2

Traduzido de: Mazzolai L, et al. Joint Consensus, ESC 2018.

Baixa	Intermediária	Alta
< 1 ponto	1 - 2 pontos	> 2 pontos

	
ACHADOS CLÍNICOS	PONTOS
Sintomas clínicos de doença tromboembólica	3
Outro diagnóstico menos provável que TEP	3
FC > 100 bpm	1,5
Imobilização ou cirurgia nas 4 últimas semanas	1,5
TEP ou TVP prévios	1,5
Hemoptise	1,5
Neoplasia maligna	1,5
Probabilidade Baixa: < 2 pontos. Probabilidade Intermediária: 2 - 6 pontos. Probabilidade Alta: > 6 pontos.	
	

- Exames complementares:
 - ECG (taquicardia sinusal S1Q3T3);
 - ECO (sinais de disfunção de VD)
 - D-dímero (indicado em pacientes de baixa probabilidade pelo Wells – sua negatividade exclui TEP)
 - angioTC (indicado para pacientes de média/alta probabilidade).

- Conduta:

- Se instável → ECO beira do leito, seguido de angioTC de emergência e trombólise química com alteplase.
- Se estável → faz D-dímero se baixo risco e (se positivo ou se alto

risco) faz angioTC, seguido de anticoagulação com rivaroxabana.

SEMANA 9: TUBERCULOSE

- Quadro clínico: febre, sudorese noturna, perda ponderal, inapetência e tosse há mais de três semanas.

- Exame físico:

→ Aparelho respiratório: MV reduzido, pode haver presença de crepitações, roncos ou sibilos.

- Diagnóstico: duas baciloscopias e/ou TRM-TB e/ou cultura + raio-x de tórax.

RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE TÓRAX	Geralmente normal, mas quando alterada pode apresentar adenopatia hilar, complexo de Ranke e nódulo de Ghon	Geralmente alterada, frequentemente nos lobos superiores, com cavidades e infiltrados. Na TC pode ter padrão de árvore em brotamento	Micronódulos difusos no parênquima pulmonar
-----------------------------------	---	--	---

- Tratamento:

- Fase intensiva: rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol. Feito por 2 meses.
- Fase de manutenção: rifampicina + isoniazida. Iniciado após a fase de ataque e dura, no mínimo, 4 meses, dependendo da apresentação clínico da tuberculose no paciente.

SEMANA 10: DPOC

- Quadro clínico: tosse crônica produtiva; dispneia aos esforços e infecção respiratória de repetição.

Obs.: Paciente com pouca exposição deve dosar alfa 1 antitripsina (se tiver deficiência realizar reposição subcutânea semanal).

- Exame físico:

- MV reduzido
- Ronco e sibilância
- Bulhas hipofonéticas
- Cianose
- Pletora facial
- Sinais de IC - casos graves
- Hipersonoridade

- Redução da expansibilidade
- Tórax em tonel

- Anamnese/perguntas:

- Qual a característica da tosse (seca/expectoração)?
- Coloração da expectoração (caso haja).
- Qual tempo de surgimento e como está a progressão (tem aumentado)?
- Tosse é intermitente ou contínua na maior parte do dia?
- Tem fator de melhora ou piora? (Decúbito, exercício, etc)
- Sintomas associados? Febre, calafrios, sudorese, vômitos/náuseas, dispneia.
- Faz uso de algum medicamento?
- Tem alguma comorbidade (HAS, diabetes, hiperlipidemia, etc)?
- É tabagista? Se sim, a quanto tempo e quantos maços ao dia?
- Trabalha com oq? Fogão a lenha, exposto a agentes tóxicos, etc)
- Alguém na família de 1º grau tem doenças pulmonares como tumor, bronquite, etc?

- Diagnóstico: Espirometria com broncodilatador (vef1/cvf <0,7)

Classificação de Gold:

Leve VEF1 >ou= a 80% do previsto;
Moderada VEF1 de 50-79% do previsto;
Grave VEF1 de 30-49% do previsto;
Muito grave VEF1 <30% do previsto

- Classificação:

Categoria	Descrição
0	Dispneia a grandes esforços
1	Dispneia ao andar rápido ou subir escadas
2	Precisa andar mais devagar que pessoas da mesma idade
3	Precisa parar p respirar após andar 100m ou em pouco tempo
4	Não sai de casa por dispneia a pequenos esforços

Estágio A: no dia a dia é pouco sintomático e exacerba pouco também (1x a cada 6 meses por exemplo e não precisa de hospitalização)

Estágio B: exacerba pouco como o A porém é mais sintomático no dia a dia

Estágio C: pouco sintomático como o A mas exacerba muito (pelo menos 2x a cada 6 meses ou 1x mas resultando em internação)

Estágio D: muito sintomático e exacerba muito

- Tratamento:

Paciente estágio A: risco baixo – somente B2-agonista de curta ação (sabutamol, comercialmente chamado de aerolin) – orienta o paciente usar quando piorar os sintomas. Se ele começar a ter que usar a bombinha em um intervalo menor que 6 em 6 horas procurar o pronto socorro.

Paciente estágio B: risco baixo - prescreve B2-agonista de longa ação (formoterol) ou anticolinérgico de longa ação (tiotropio)

Paciente estágio C: alto risco – budesonida (corticoide) + formoterol (B2 agonista de longa ação) OU anticolinérgico de longa ação (tiotropio – melhor escolha)

Paciente estágio D: alto risco – Anticolinérgico de longa ação (tiotropio- nome comercial é spiriva) associado a um B2 agonista de longa ação (formoterol) e pode também associar a um corticoide (budesonida)

SEMANA 11: SÍNDROMES PLEURAIAS

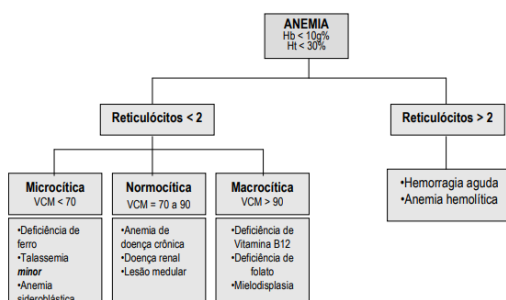
- Quadro clínico: falta de ar, tosse e dor torácica.

- Exame físico: MV abolido e crepitações difusas.

01	Descreveu as alterações da radiografia do tórax: Velamento homogêneo do hemitórax esquerdo; apagamento do seio costofrênico esquerdo; apagamento do seio cardiofrênico esquerdo. Sim (as 3) = 1,0 Sim (apenas 2) = 0,5 1 <u>OU</u> não descreveu = 0,0
02	Identificou as principais hipóteses diagnósticas (derrame pleural à esquerda <u>E</u> quilotórax). Sim (as duas) = 1,0 Sim (apenas uma) = 0,5 Não identificou = 0,0
03	Esclareceu que o quadro clínico ocorreu por lesão do ducto torácico, secundária à punção da veia subclávia esquerda, durante sua internação. Sim (resposta completa) = 1,0 Sim (apenas lesão do ducto torácico) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
04	a) Esclareceu sobre a inexistência de medicação para tratamento do quadro. Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Esclareceu sobre a operação (drenagem torácica) Sim = 0,5 Não esclareceu = 0,0

05	Esclareceu que o tratamento inicial é conservador , com drenagem torácica para retirada do líquido pleural e DIETA para o quadro (via oral, pobre em gordura OU jejum oral + dieta parenteral total) Sim (os 3) = 1,0 Sim (apenas 2) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
06	a) Esclareceu sobre a necessidade de internação hospitalar. Sim = 0,5 Não = 0,0 b) Esclareceu sobre a necessidade de anestesia local, na região de introdução do dreno torácico. Sim = 0,5 Não = 0,0
07	Esclareceu sobre o tempo do tratamento conservador (no máximo, 14 dias). Sim (máximo 14 dias) = 1,0 Sim (entre 7 e 13 dias) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
08	Esclareceu sobre a necessidade de cirurgia, no caso de persistência do débito quiloso pelo dreno torácico. Sim = 1,0 Não = 0,0
09	Esclareceu sobre as possibilidades cirúrgicas (ligadura do ducto torácico, por videotoracoscopia OU toracotomia, com ou sem pleurodese). Sim (as duas) = 1,0 Sim (apenas uma) = 0,5 Não esclareceu = 0,0
10	Ao final da consulta, perguntou ao paciente se todas as suas dúvidas foram esclarecidas. Sim = 1,0 Não = 0,0

SEMANA 13: ANEMIAS



1. Anemia ferropriva

DIAGNÓSTICO

- Hemograma com anemia microcítica e hipocrômica.
- Ferritina < 10 ng%
- Ferro sérico < 30mcg% , o que denota baixo estoque.

TRATAMENTO

- Suporte nutricional

- Reposição de ferro, preferencialmente por via oral: 900mg/dia (180mg de ferro elementar), divididos em 3 tomadas.
- A transfusão de hemácias deverá ser reservada para pacientes com sintomas que denotam grave hipóxia tecidual.

2. Anemia megaloblástica

Pode ser causada por deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, que ocorre por baixa ingestão (deficiência de folato) ou por impacto na absorção, como é o caso da anemia perniciosa (deficiência de vitamina B12).

DIAGNÓSTICO

- Neutrófilos plurisegmentares no sangue periférico.
- Pancitopenia.
- Dosagem de ácido fólico e vitamina B12.
- Dosagens séricas de ácido metilmalônico e homocisteína são usadas para confirmação diagnóstica.

TRATAMENTO

- Investigar as principais causas da deficiência de ácido fólico: nutricional, má absorção intestinal e uso de anticonvulsivantes, pirimetamina, trimetoprim e álcool.
- Tratar com ácido fólico via oral, 5 mg/dia via oral e/ou vitamina B12 intramuscular.

3. Talassemia

É uma doença hereditária resultante de um defeito genético na síntese de uma ou mais cadeias globínicas da hemoglobina. Há dois principais tipos de talassemia - alfa (cromossomo 11) e beta (cromossomo 16).

DIAGNÓSTICO

- Hemograma com microcitose, hipocromia e reticulócitos aumentados
- A eletroforese de hemoglobina apresenta elevação da hemoglobina A2 nas beta-talassemias.

TRATAMENTO

- O tratamento varia de simples observação e acompanhamento, nas formas mais brandas (alfa talassemia ou

beta talassemia minor), até transfusões sanguíneas frequentes e esplenectomia, nas formas mais severas (beta talassemia major).

4. ANEMIA FALCIFORME

Ocorre por mutação que substitui o ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia β da globina. A hemácia com a globina mutante quando desoxigenada torna a clássica forma de foice, perdendo a flexibilidade necessária para atravessar os pequenos capilares. Os heterozigotos para a mutação apresentam uma entidade benigna (traço falciforme), sem ocorrência de anemia ou obstrução vascular.

DIAGNÓSTICO

- Anemia crônica, crises de dor osteoarticular, icterícia e história familiar frequentemente positiva.
- Eletroforese de hemoglobina que detecta a presença da hemoglobina mutante (Hemoglobina S).

TRATAMENTO

- Transfusões com concentrado de hemácias lavadas nos casos de hemoglobina $< 7g\%$.
- Evitar a ocorrência de fatores que precipitam a crise falcêmica, como desidratação, acidose, hipotensão arterial, hipoxemia e infecção.

SEMANA 14: ARBOVIROSES/DENGUE

Quadro clínico: Cefaleia, Dor retroorbitária, Mialgia, Exantema, Febre alta, Artralgia.

- Fase crítica:
 - S: sangramento das mucosas
 - I: irritabilidade
 - L: líquido acumulado
 - V: vômitos persistentes
 - A: abdome doloroso
 - H: hipotensão postural
 - H: hepatomegalia
 - H: hematócrito elevado
- Fase grave:

- Taquicardia.
- Extremidades distais frias.
- Pulso fraco e filiforme.
- Enchimento capilar lento (> 2 segundos).
- Pressão arterial convergente (< 20 mmHg).
- Oligúria ($< 1,5$ ml/kg/h).
- Hipotensão arterial.
- Cianose.

Exames complementares:

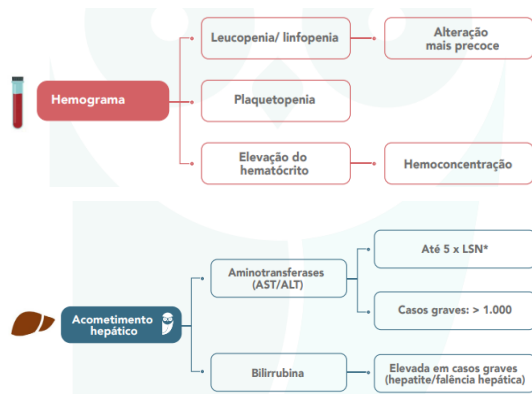
A) Prova do laço:

1. Verificar a pressão arterial sistólica (PAS) e diastólica (PAD) e calcular o valor médio pela fórmula $(PAS + PAD)/2$.
2. Insuflar o manguito até o valor médio e manter durante cinco minutos em adultos e três minutos em crianças.
3. Desenhar um quadrado com 2,5 cm de lado no antebraço e contar o número de petéquias formadas em seu interior. A prova será positiva se houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças. Quando positiva, o paciente passa a ser do grupo B da dengue.

B) Exame sorológico: O exame sorológico utiliza o método ELISA. Detecta anticorpos IgM e deve ser solicitado a partir do sexto dia após o início dos sintomas. Esse é o método mais frequentemente empregado para diagnóstico de dengue.

C) PCR/NR1: Exames que detectam o vírus devem utilizar amostras coletadas até o quinto dia de sintomas. Pesquisa do antígeno NS1.

D) Exames laboratoriais:



CLASSIFICAÇÃO:



- Comorbidades e condições especiais e/ou de risco:
- Idade < 2 anos ou > 65 anos.
- Gestantes.
- Hipertensão arterial sistêmica ou doenças cardiovasculares graves.
- Diabetes mellitus.
- Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- Doença renal crônica.
- Doença ácido péptica.
- Hepatopatias.
- Doenças autoimunes.

TRATAMENTO

